UE B1.3 · SEMESTRE 1

HÉPATITES VIRALES

Fiche de révision écrite

Cours du Pr Anne-Marie Roque-Afonso · Support officiel et notes de cours

Pourquoi cette fiche ?

Comprendre l'atteinte du foie, distinguer les transmissions et expliquer au patient les examens et la prévention. Relier les résultats biologiques à leur sens, sans confondre infection, immunisation et guérison.

Objectifs explicitement annoncés

Définir l'hépatite et ses complications ; expliquer les transmissions, les bases du diagnostic biologique et les principes de prévention.

Une lecture en trois temps

Définir la notion, comprendre son mécanisme, puis l'appliquer à une situation de soin. Les tableaux servent à comparer ; les notes éclairent les nuances de la séance.

Une démarche pour expliquer un résultat

Étape	Question à se poser
1 · Situer	Atteinte aiguë ou chronique ? Symptômes ou dépistage ?
2 · Distinguer	Quel virus et quelle voie de transmission ?
3 · Lire	Antigène, anticorps ou génome viral : que mesure le test ?
4 · Relier	Quelle prise en charge et quelle prévention sont concernées ?

Sommaire rapide — accès direct aux chapitres

Foie et gravité · p. 2

Transmission A / E · p. 5

Diagnostic et prévention A / E · p. 6

B / C : transmission et dépistage · p. 7

Comprendre les marqueurs · p. 9

Prévention et vaccination · p. 11

Pièges et synthèse · p. 14

Définitions et mots-clés · p. 16

Réflexe de soin

Expliquer sans conclure trop vite : une personne sans symptôme peut être infectée ; un anticorps positif ne signifie pas toujours présence de virus actif.

01 Comprendre ce qu'est une hépatite

Essentiel

Une hépatite est une inflammation du foie. Elle peut être aiguë ou chronique et n'est pas nécessairement virale. Une personne peut être infectée sans présenter de symptômes.

Le foie : fonctions et capacité de régénération

Le foie est situé sous le diaphragme, principalement à droite. Le cours donne un ordre de grandeur de 1,5 kg, soit environ 2 % du poids corporel. Il participe au contrôle métabolique et au stockage des sucres et des graisses, à la production de protéines comme l'albumine et les facteurs de la coagulation, ainsi qu'à la transformation de l'ammoniaque en urée.

Sa capacité de régénération explique la possibilité d'une transplantation à partir d'un donneur vivant : une partie du foie peut être prélevée, tandis que le foie restant et le greffon peuvent se développer. Cette capacité ne signifie pas que toute lésion hépatique est réversible ni qu'une cirrhose soit sans conséquence.

Définir, repérer, comprendre

Notion	Explication à retenir
Hépatite	Hêpatos signifie foie ; le suffixe -ite indique une inflammation. Le mot décrit l'atteinte de l'organe, pas sa cause.
Aiguë / chronique	L'atteinte aiguë et l'atteinte chronique n'ont pas la même évolution. Le cours situe la chronicité au-delà de six mois.
Transaminases ALAT / ASAT	Ces enzymes augmentent dans le sang lorsque des hépatocytes lésés en libèrent. Leur élévation est le repère biologique de l'atteinte hépatique présenté dans le cours.
Signes cliniques	L'atteinte est souvent asymptomatique ; une fatigue peut être le seul signe non spécifique. Une cholestase peut s'accompagner d'un ictère.

Pour comprendre

Une hausse des transaminases renseigne sur une atteinte cellulaire ; elle ne nomme pas le virus responsable. La recherche de la cause nécessite des examens spécifiques.

Expliquer au patient

« Le bilan montre que votre foie est atteint. Cela ne permet pas encore de dire quelle en est la cause. Les examens complémentaires servent à la préciser, même si vous vous sentez bien. »

02 Distinguer les deux trajectoires de gravité

Deux évolutions à ne pas confondre

L'hépatite fulminante correspond à une défaillance aiguë grave. La fibrose, la cirrhose et le cancer s'inscrivent dans une évolution chronique, parfois longtemps silencieuse.

Gravité aiguë : insuffisance hépatique et encéphalopathie

Le cours décrit l'hépatite fulminante par l'association d'une insuffisance hépatique aiguë et d'une encéphalopathie hépatique. La baisse importante des facteurs de la coagulation traduit la défaillance de synthèse du foie et expose à des manifestations hémorragiques. L'encéphalopathie se manifeste par des troubles de la conscience pouvant aller jusqu'au coma.

Une défaillance d'autres organes, notamment rénale ou cardiaque, peut s'associer. Ces formes mettent en jeu le pronostic vital. Le raisonnement infirmier consiste à reconnaître la gravité de l'association des signes et à transmettre rapidement les observations ; la seule intensité de la jaunisse ne résume pas la situation.

Gravité chronique : inflammation, fibrose et cirrhose

Lorsque l'inflammation persiste, du tissu cicatriciel peut se constituer : c'est la fibrose. Son évolution peut aboutir à une cirrhose, qui modifie l'architecture et le fonctionnement du foie. Une cirrhose peut se compliquer d'un cancer du foie. L'absence de symptôme pendant plusieurs années ne signifie donc pas absence d'évolution.

Le cours relie l'augmentation de la résistance à la circulation dans le foie à une hypertension portale. Une ascite et une circulation veineuse collatérale peuvent apparaître. L'ascite correspond à une accumulation de liquide dans la cavité abdominale ; les voies collatérales constituent des voies de dérivation de la circulation.

Situation	Raisonnement
Troubles de la conscience et anomalies de coagulation dans une atteinte aiguë	Évoquer une forme grave et transmettre les constatations sans attendre de réduire le problème à une simple fatigue.
Infection chronique sans symptôme	Comprendre l'intérêt du dépistage et du suivi avant l'apparition d'une cirrhose ou d'un cancer.
Hépatite fulminante ou maladie chronique sévère	Le cours les présente comme des indications potentielles de transplantation, selon l'évaluation spécialisée.

03 Situer les causes et les différences entre virus

Hépatite ne signifie pas automatiquement infection virale

Atteinte aiguë : causes citées	Atteinte chronique : causes citées
Médicaments, notamment surdosage en paracétamol ; champignons ; virus ; auto-immunité.	Alcool ; causes métaboliques dont la MASH ; virus ; auto-immunité.
Le support met en avant les virus A, B et E dans ce chapitre.	Le support met en avant B, C et D, ce dernier étant lié à l'infection B.

La MASH est une stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique. Elle rappelle qu'une maladie du foie peut relever d'un mécanisme métabolique plutôt que d'une contamination. L'existence d'une hépatite ne suffit donc ni à conclure à une contagiosité ni à identifier un mode de transmission.

Points communs des hépatites virales étudiées

Les formes asymptomatiques sont fréquentes. Une infection chronique peut rester silencieuse pendant des années ; une infection aiguë peut aussi être contagieuse avant les signes. Le dépistage vise à identifier une infection avant les complications et à réduire la transmission.

L'incubation est l'intervalle entre la contamination et l'apparition éventuelle de symptômes. Le cours insiste sur sa longueur : plusieurs semaines, avec une durée pouvant aller jusqu'à plusieurs mois pour B. Il ne faut pas attendre l'apparition d'un ictère pour penser au risque d'infection.

Comparer	A et E dans le chapitre aigu	B et C dans le chapitre chronique
Structure enseignée	Virus nus, résistants aux conditions du milieu digestif.	Virus enveloppés ; modes de transmission liés aux contacts et aux liquides biologiques.
Voie dominante étudiée	Ingestion, avec des réservoirs et des circonstances différents pour A et E.	Transmission sanguine ; pour B, transmission sexuelle et mère-enfant également importantes.
Diagnostic	Examens spécifiques à chaque virus.	Marqueurs B distincts des anticorps et de l'ARN recherchés pour C.

Portée de la comparaison

Cette organisation reprend les chapitres du cours. Elle ne permet pas de déduire qu'un virus non détaillé ne pourrait jamais donner une autre forme clinique. Le virus D est seulement situé ici, sans ajouter un chapitre absent des sources.

04 A et E : même porte d'entrée, réservoirs différents

Le mécanisme digestif

Dans le modèle étudié, A et E sont ingérés, traversent le tube digestif puis gagnent le foie par la circulation porte. Après multiplication hépatique, les particules peuvent rejoindre l'intestin par la bile et être excrétées dans les selles.

Point de comparaison	Hépatite A	Hépatite E : situations étudiées
Réservoir	Humain.	Animal dans les pays riches, notamment porc et sanglier : réservoir zoonotique.
Origine de la contamination	Selles d'une personne infectée, puis contamination des mains, objets, surfaces, eau ou aliments.	Animal infecté : consommation de produits à base de porc crus ou insuffisamment cuits ; contact avec des animaux infectés.
Transmission	Féco-orale, directe ou indirecte.	Alimentaire et liée à certaines expositions animales dans le contexte présenté.
Exemples du cours	Mains contaminées, préparation d'aliments, fruits ou légumes contaminés, coquillages.	Produits contenant du foie de porc, dont le figatellu consommé cru ; exposition professionnelle ou lors de la chasse.

Comprendre la contagiosité avant les symptômes

Pour A, le support situe la contagiosité environ quinze jours avant et dix jours après le début des symptômes. Une personne qui se sent bien peut donc excréter du virus et contaminer son entourage. Le lavage des mains et la sécurité alimentaire concernent aussi des personnes sans symptôme apparent.

Pourquoi certains aliments sont-ils concernés ?

L'explication orale relie des contaminations alimentaires à une eau souillée lors de la production ou de la préparation. Des lots de fruits ou légumes surgelés peuvent distribuer largement un même aliment contaminé : la surgélation ne doit pas être assimilée à une stérilisation.

Les coquillages filtrent l'eau et peuvent concentrer des contaminants lorsque l'environnement est souillé. Cette explication permet de relier l'aliment au circuit de contamination, sans présenter tous les produits surgelés ou tous les coquillages comme systématiquement infectés.

Application

Devant un cas A, rechercher le raisonnement selles → mains/eau/aliments → ingestion. Devant une exposition E dans le contexte du cours, rechercher notamment un produit porcin cru ou insuffisamment cuit, ou un contact animal pertinent.

05 A et E : diagnostic et prévention raisonnée

Devant une hépatite aiguë symptomatique

Le cours décrit une fatigue, parfois une fièvre modérée et un ictère. Une élévation franche des transaminases peut accompagner l'atteinte virale aiguë : le support donne un ordre de grandeur de dix à cent fois la normale. Cette intensité ne suffit pas à identifier le virus.

Recherche enseignée	Ce que le bilan explore
IgM anti-VHA	Diagnostic de l'hépatite A aiguë.
IgM anti-VHE	Diagnostic de l'hépatite E aiguë.
AgHBs, anti-HBs, anti-HBc	Bilan des trois marqueurs de l'hépatite B.
Anticorps totaux anti-VHC	Dépistage de l'hépatite C ; recherche d'ARN si nécessaire dans le parcours décrit ensuite.

Le support cite environ 1 000 hépatites A et 3 000 hépatites E diagnostiquées par an en France. Ce sont les repères chiffrés du cours, et non une estimation épidémiologique actualisée. Le point pédagogique est leur place dans les hépatites aiguës étudiées.

Relier chaque mesure à son mode de transmission

Hépatite A	Hépatite E dans le contexte du cours
Hygiène individuelle : lavage des mains, notamment après les toilettes et avant de préparer les aliments.	Cuisson à cœur des aliments à base de porc ; ne pas confondre viande préparée ou séchée avec viande cuite.
Hygiène collective : traitement des eaux usées et sécurité des aliments.	Protection lors des contacts animaux professionnels : équipements tels que gants et bottes, selon l'exposition.
Vaccin inactivé : le cours cite voyageurs exposés, cas contacts et personnes ayant une maladie du foie.	Le support indique l'absence de vaccin commercialisé en Europe au moment de son élaboration.
Déclaration obligatoire et mesures de gestion : identifier les cas contacts, rechercher un lot alimentaire, rappeler les mesures d'hygiène.	Le support n'indique pas d'isolement spécifique pour les situations E étudiées.

Mesures hospitalières présentées

Le cours associe A hospitalisée à des précautions de contact. Ces repères de cours ne remplacent pas les consignes de l'équipe d'hygiène et les protocoles de l'établissement. L'absence d'isolement spécifique cité pour E ne supprime pas les précautions habituelles de soin.

06 B et C : transmission et risque de chronicité

Des contacts différents selon le virus

B et C sont présentés comme des virus enveloppés à réservoir humain. Le cours oppose leur transmission parentérale à la transmission digestive de A et E. Le terme parentéral, pris au sens large dans cette comparaison, ne doit pas faire oublier de nommer précisément la voie en cause.

Hépatite B	Hépatite C
Le cours décrit plusieurs liquides biologiques potentiellement contaminants : sang et sécrétions génitales notamment. Les voies sanguine, sexuelle et mère-enfant sont à connaître.	La voie sanguine est centrale : matériel d'injection partagé, exposition au sang, transfusion ou soins non sécurisés.
La voie dominante dépend du contexte d'endémie : l'oral oppose transmission sexuelle dans un contexte de faible endémie et transmission mère-enfant dans les zones de forte endémie.	L'oral précise le risque sexuel dans certaines situations, notamment chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et vivant avec le VIH. Ne pas transformer la formule « voie sanguine » en absence absolue de risque lors de tout rapport.

Chronicité : le moment de la contamination compte pour B

Repère du support	Conséquence pédagogique
B : plus de 90 % si contamination avant un an	Une infection très précoce expose fortement à la persistance ; la prévention mère-enfant est essentielle.
B : environ 5 % après contamination à l'âge adulte	Le risque est plus faible qu'en période néonatale ; il n'est pas nul.
C : 60 à 80 %	Le passage à la chronicité est fréquent dans les données enseignées, ce qui justifie dépistage et prise en charge.

Le support cite environ 130 000 infections B chroniques et moins de 100 000 infections C chroniques en France. Ces valeurs sont des repères de la séance, sans actualisation indépendante. L'oral explique la diminution des infections C chroniques par l'efficacité des nouveaux traitements.

Pourquoi dépister tôt ?

Une infection chronique peut rester asymptomatique alors que le foie s'altère. Dépister permet de traiter ou de suivre avant les complications, et de prévenir de nouvelles transmissions.

07 Qui dépister, et dans quel but ?

Une logique de prévention

Le dépistage ne répond pas seulement à des symptômes. Il tient compte des expositions, des situations à risque et, pour B, de la protection du nouveau-né.

Situation citée dans le cours	B	C
Personnes transfusées, usages de drogues, exposition au sang	Dépistage cité.	Dépistage cité.
Personnes venant de zones où l'infection est fréquente ; population carcérale	Le cours relie ces situations à une fréquence accrue d'expositions ou d'infections.	Même raisonnement d'exposition et de prévalence, sans assimiler une origine à un diagnostic.
Accident d'exposition au sang (AES)	Bilan B cité, avec évaluation du patient source dans le circuit prévu.	Bilan C cité ; l'oral rappelle également la recherche du VIH.
Grossesse	Toutes les femmes enceintes figurent dans le support pour prévenir la transmission mère-enfant.	Le support ne présente pas le même dépistage systématique de toutes les grossesses.
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, notamment VIH+	Les facteurs d'exposition sont à considérer.	Population explicitement citée dans le support.
Population générale	Le support propose au moins un dépistage au cours de la vie.	Même proposition dans le support.

La liste du cours sert à comprendre le raisonnement : repérer une exposition et permettre une prise en charge avant les complications. Les indications et le calendrier d'un bilan individuel relèvent du professionnel prescripteur et du contexte de soin ; une fiche de révision ne décide pas seule des examens.

Grossesse : distinguer principe et calendrier

Le principe clairement enseigné est le dépistage maternel B pour organiser la protection de l'enfant. L'oral situe ce dépistage tôt dans la grossesse ; le calendrier réglementaire n'est pas détaillé ici.

Éviter une conclusion stigmatisante

Une personne appartenant à une population citée n'est pas nécessairement infectée. Le dépistage permet de connaître son statut ; il ne doit pas être remplacé par une supposition fondée sur son origine, son orientation sexuelle ou son parcours.

08 B : lire les trois marqueurs ensemble

Identifier ce qui est mesuré

Marqueur	Signification dans le raisonnement
AgHBs	Antigène de surface du virus B. Sa détection traduit une infection en cours dans l'algorithme du cours.
Anticorps anti-HBs	Anticorps dirigés contre cet antigène de surface. Ils peuvent être produits après vaccination ou après une infection contrôlée.
Anticorps anti-HBc	Anticorps dirigés contre l'antigène de capside. Ils témoignent d'un contact avec le virus ; le vaccin fondé sur HBs ne les fait pas apparaître.

Les quatre profils de l'algorithme enseigné

AgHBs	Anti-HBs	Anti-HBc	Lecture du profil
–	–	–	Profil naïf : aucune rencontre identifiée par ce bilan ; vaccination à envisager dans le parcours prévu.
–	+	–	Profil vaccinal : anti-HBs isolés.
–	+ ou –	+	Profil présenté comme infection ancienne dans le cours. Interpréter les marqueurs ensemble et avec le contexte clinique.
+	–	+	Infection en cours : compléter l'interprétation et organiser la prise en charge.

Lorsque l'AgHBs est découvert positif, le support décrit une recherche réflexe d'IgM anti-HBc par le laboratoire. Des IgM positives orientent vers une infection aiguë probable. Le schéma du cours oriente vers une infection chronique lorsque ces IgM sont négatives ; l'interprétation doit rester reliée à l'histoire et à la durée de l'infection. La chronicité n'est pas une simple lecture isolée d'un anticorps.

Du résultat à la prise en charge

Une infection B en cours conduit à une évaluation spécialisée. Tous les patients ne reçoivent pas le même traitement. Le cours insiste sur la durée prolongée du traitement lorsqu'il est indiqué et sur le rôle infirmier dans l'adhésion et le suivi.

Question discutée en séance

Une infection par le VIH ne signifie pas automatiquement une infection B. Les modes de transmission peuvent être communs, ce qui justifie de rechercher les deux ; un traitement doit tenir compte d'une éventuelle co-infection. Seul un bilan adapté permet de connaître le statut B.

09 C : anticorps, ARN et perspective de traitement

Deux questions différentes

La sérologie recherche une trace immunitaire de rencontre avec le VHC. La recherche d'ARN viral renseigne sur la présence du virus dans le sang. Un anticorps positif ne suffit pas, à lui seul, à conclure à une infection active.

Étape	Résultat	Interprétation du parcours enseigné
Anticorps totaux anti-VHC	Négatifs	Pas d'anticorps détectés dans ce bilan. Le résultat se comprend dans son contexte de prescription.
Anticorps totaux anti-VHC	Positifs	Rechercher l'ARN du VHC, ou charge virale, pour distinguer contact ancien et infection active.
ARN du VHC après sérologie positive	Non détecté	Le schéma du cours indique une infection guérie : des anticorps peuvent persister sans virus circulant détecté.
ARN du VHC après sérologie positive	Détecté	Infection active : prise en charge et traitement à organiser.

Ce que le traitement change

Le cours présente les traitements oraux de l'hépatite C comme une avancée majeure : une durée de deux à trois mois est indiquée selon le traitement choisi. L'objectif est la guérison virologique, évaluée dans le suivi. L'oral insiste sur la prise en charge des infections C actives et sur la possibilité de guérir, plutôt que d'attendre une complication.

Les anticorps anti-VHC peuvent rester positifs après la guérison. Leur persistance ne signifie donc pas, à elle seule, échec du traitement. La distinction sérologie / ARN doit être expliquée au patient pour éviter qu'il interprète une sérologie persistante comme la preuve que le virus est toujours présent.

Accompagner l'annonce sans promettre

« Ce résultat permet d'organiser votre prise en charge. La recherche du virus précisera la situation. Il existe des traitements efficaces ; l'équipe vous expliquera celui qui vous convient et comment vérifier son résultat. »

Rôle infirmier

Vérifier la compréhension, soutenir l'adhésion, recueillir les difficultés et les transmettre. Le message rassurant porte sur l'existence d'une prise en charge efficace ; il ne remplace pas l'annonce médicale ni le contrôle de guérison.

10 Prévenir B et C par plusieurs moyens complémentaires

Agir sur les occasions de transmission

Mesure citée	Mécanisme de prévention
Préservatif	Réduire le risque lors d'expositions sexuelles pertinentes et participer à la prévention des infections sexuellement transmissibles.
Réduction des risques liés aux drogues	Ne pas partager le matériel d'injection ; accéder à du matériel stérile et aux programmes d'échange.
Sécurisation des soins	Respecter les procédures de soin et d'usage du matériel ; le cours insiste sur le matériel à usage unique.
Sécurisation des dons de sang et d'organes	Rechercher les infections chez les donneurs et sécuriser les produits destinés aux receveurs.
Dépistage	Identifier une infection pour la prendre en charge ; pour B, identifier aussi une personne susceptible de bénéficier de la vaccination.

Donneur et don : deux contrôles expliqués à l'oral

L'enseignante distingue les examens du donneur et la recherche directe de génomes viraux dans le don de sang lui-même. Le DGV, dépistage du génome viral, recherche notamment les génomes de B, de C et du VIH. La PCR est présentée comme un moyen de détecter le matériel génétique viral.

L'intérêt pédagogique est la complémentarité de plusieurs barrières de sécurité. Dire qu'un circuit est sécurisé ne revient pas à promettre un risque nul. L'explication ne doit pas être transformée en liste réglementaire exhaustive ou en procédure autonome de validation d'un produit sanguin.

La vaccination ne protège pas contre toutes les hépatites

La vaccination B complète les mesures de prévention ; elle ne dispense pas des précautions liées au sang ni de la prévention des autres infections. Le cours distingue cette possibilité de l'absence de vaccin contre C. Pour C, dépister et traiter contribue à réduire les conséquences de l'infection et sa transmission.

Application au soin

Une personne vaccinée contre B reste concernée par les procédures de prévention des AES. Son statut vaccinal B ne permet pas de conclure qu'elle est protégée contre C ou contre le VIH.

11 Vaccination B : vaccin, immunisation et non-réponse

Un vaccin sous-unitaire

Le vaccin B contient l'antigène de surface HBs, et non un virus B entier. Il entraîne la production d'anticorps anti-HBs. Cela explique le profil sérologique vaccinal sans anti-HBc.

Les schémas présentés dans le support

Repère enseigné	À comprendre
Trois injections : 0, 1 et 6 mois	Schéma de référence présenté dans la diapositive. Un calendrier individuel ou pédiatrique doit être vérifié dans le cadre médical approprié.
Schéma accéléré : J0, J7, J21 puis une injection à 12 mois	Les trois premières injections rapprochées ne constituent pas à elles seules l'intégralité du schéma présenté.
Obligation chez les personnels de santé ; certificat pour l'entrée en études infirmières	Le support distingue la vaccination de la preuve d'immunisation établie par un médecin.
Vaccination des enfants, obligatoire depuis 2018 selon le support	Ne pas confondre obligation de vaccination et injection systématique à la naissance pour tous les enfants. La sérovaccination à la naissance concerne la situation maternelle décrite au chapitre suivant.

La non-réponse n'est pas une simple injection oubliée

Le cours définit le non-répondeur par l'absence de réponse anti-HBs après deux schémas complets, soit six injections dans la présentation enseignée. Il ne suffit pas de constater une absence d'anticorps après une seule injection pour classer une personne non-répondeuse. L'interprétation du résultat et la conduite à tenir relèvent du médecin.

L'oral cite l'âge, l'obésité, l'immunodépression et la cirrhose parmi les facteurs pouvant diminuer la réponse. Ces facteurs n'autorisent pas à prédire à eux seuls le statut d'une personne. Le contrôle de l'immunisation reste essentiel.

En cas d'AES

Une personne identifiée non-répondeuse n'est pas considérée protégée par sa seule histoire vaccinale. Le cours prévoit des immunoglobulines dans certaines expositions à une source infectée B. Le statut doit être connu et transmis dans le circuit médical d'AES ; ne pas improviser une prescription à partir de cette fiche.

12 Prévenir la transmission mère-enfant de B

Anticiper pendant la grossesse

Le dépistage maternel permet d'identifier une infection B et de préparer la protection de l'enfant. Le marqueur utilisé pour repérer l'infection en cours est l'AgHBs. Il ne faut pas le confondre avec l'anticorps anti-HBs, qui peut témoigner d'une réponse vaccinale.

L'oral explique qu'une charge virale maternelle élevée augmente le risque de transmission et peut justifier une prise en charge spécialisée visant à la réduire. Aucun seuil chiffré de décision thérapeutique n'est à déduire de cette fiche. L'évaluation maternelle et les indications de traitement relèvent de l'équipe médicale.

Sérovaccination du nouveau-né de mère AgHBs positive

Action enseignée	But
Intervenir dans les douze heures suivant la naissance	Agir rapidement dans la situation à risque identifiée.
Administrer une première injection vaccinale	Déclencher une réponse immunitaire propre à l'enfant.
Administrer des immunoglobulines spécifiques, séparément du vaccin	Apporter immédiatement des anticorps ; l'oral décrit les deux injections dans des cuisses différentes.
Poursuivre le schéma vaccinal puis organiser le contrôle	Ne pas réduire la prévention à l'acte de naissance : le suivi vérifie la protection et recherche une éventuelle transmission.

Deux mécanismes complémentaires

Le vaccin prépare une protection active ; les immunoglobulines apportent une protection passive immédiate. La sérovaccination associe les deux, elle ne désigne pas un simple prélèvement sérologique.

Une charge virale mesurée à un moment donné ne doit pas être assimilée à elle seule à l'état du foie ou à une guérison. Le cours insiste sur la nécessité d'une évaluation et d'un suivi, notamment pendant la grossesse et après la prévention néonatale.

Transmettre de façon précise

Dans la préparation de la naissance, distinguer le statut maternel AgHBs, l'organisation de la sérovaccination, les injections effectivement réalisées et la suite du suivi. Dire seulement « la mère a des anticorps » ne décrit pas correctement une infection B en cours.

Pièges QCM / confusions à éviter

Confusion	Raisonnement correct
Hépatite = forcément un virus	Hépatite signifie inflammation du foie ; médicaments, alcool, métabolisme ou auto-immunité figurent aussi parmi les causes.
Absence d'ictère = absence d'infection	Les formes asymptomatiques sont fréquentes ; contagiosité et chronicité peuvent précéder les signes.
Transaminases élevées = virus identifié	Elles orientent sur l'atteinte hépatique ; les examens étiologiques identifient la cause.
A et E = exactement le même circuit	La porte d'entrée digestive est commune dans le cours, mais le réservoir et l'origine de la contamination diffèrent.
Produit surgelé ou séché = produit stérile	Le mode de préparation ne prouve pas l'inactivation des virus.
VHC sanguin = aucun risque sexuel imaginable	La nuance orale sur certaines situations d'exposition doit être conservée.
VIH positif = VHB automatiquement positif	Des risques communs justifient des dépistages distincts ; ce sont des virus différents.
Anti-HBs et AgHBs = même résultat	Un anticorps contre HBs et la détection de l'antigène HBs n'ont pas la même signification.
Vacciné B = anti-HBc positifs	Le profil vaccinal présenté comporte des anti-HBs isolés, sans anti-HBc.
Un anticorps isolé suffit à dater B	Les trois marqueurs, l'histoire et la durée d'évolution doivent être mis en relation.
Anti-VHC positifs = forcément virus actif	La recherche d'ARN permet de distinguer une infection active d'un contact avec infection guérie dans le parcours du cours.
Anti-VHC persistants après traitement = échec certain	Les anticorps peuvent persister malgré la guérison virologique.
Vaccin B = protection contre C et VIH	Les protections sont spécifiques ; les précautions de soin restent nécessaires.
Trois injections accélérées = suivi terminé	Le support ajoute une injection à douze mois.
Vaccination obligatoire = forcément immunisé	Le statut d'immunisation doit être établi ; une non-réponse est possible.
Sérovaccination = vaccin seul	Elle associe vaccin et immunoglobulines dans la situation néonatale enseignée.
AgHBs maternel = anti-HBs maternel	AgHBs positif repère l'infection maternelle ; ne pas confondre antigène et anticorps.
Dépister sert seulement à diagnostiquer tardivement	Il sert à prendre en charge avant les complications et à prévenir la transmission.

Synthèse générale — L'essentiel du cours

Le fil directeur

Définir l'atteinte du foie, rechercher sa cause, distinguer les transmissions, interpréter les bons marqueurs et relier le résultat à une prévention adaptée.

1 · Atteinte et gravité

Une hépatite peut être aiguë ou chronique, virale ou non virale. Les transaminases sont le repère biologique présenté ; l'absence de symptôme n'exclut pas l'infection. L'association d'insuffisance hépatique aiguë et de troubles de conscience évoque la gravité fulminante ; une évolution chronique peut conduire à fibrose, cirrhose et cancer.

2 · Transmission

A : réservoir humain et transmission féco-orale. E : dans le contexte étudié, réservoir animal et exposition alimentaire ou animale. B : voies sanguine, sexuelle et mère-enfant. C : voie sanguine dominante, avec les nuances de certaines expositions sexuelles données à l'oral.

3 · Diagnostic

A et E aiguës : IgM spécifiques dans le bilan enseigné. B : interpréter ensemble AgHBs, anti-HBs et anti-HBc. C : anticorps anti-VHC, puis ARN pour établir la présence de virus circulant. Distinguer anticorps de protection ou de contact, antigène et génome viral.

4 · Prévention et rôle infirmier

Relier les mesures au circuit de transmission : mains/eaux/aliments pour A ; cuisson et protection animale pour E ; prévention des expositions, matériel adapté et sécurité des dons pour B/C. La vaccination B et la sérovaccination néonatale ont une place spécifique. Expliquer, vérifier la compréhension, soutenir l'adhésion et transmettre des observations précises sans extrapoler un protocole individuel.

Trois questions de relecture

Puis-je expliquer la différence entre infection silencieuse et absence d'infection ? Puis-je distinguer AgHBs, anti-HBs et anti-HBc ? Puis-je expliquer pourquoi des anti-VHC positifs nécessitent de regarder aussi l'ARN ?

Définitions et mots-clés — Le foie et ses atteintes

01 · Hépatite : Inflammation du foie, aiguë ou chronique, dont la cause peut être virale ou non virale.

02 · Hépatocyte : Cellule majoritaire du foie, impliquée dans ses fonctions métaboliques et de synthèse.

03 · Hépato- / -ite : Hépato- renvoie au foie ; le suffixe -ite indique une inflammation.

04 · Régénération hépatique : Capacité du foie à reconstituer une partie de son volume, à l'origine notamment de la possibilité de don vivant partiel.

05 · Transaminases : Enzymes dont l'augmentation sanguine accompagne une atteinte cellulaire hépatique dans le cours ; les principales citées sont ALAT et ASAT.

06 · ALAT / ASAT : Alanine aminotransférase et aspartate aminotransférase : enzymes dosées dans le bilan biologique évoqué.

07 · Cholestase : Diminution ou perturbation de l'écoulement biliaire, associée dans le cours à une accumulation des constituants de la bile.

08 · Ictère : Coloration jaune de la peau et des muqueuses, appelée jaunisse ; signe possible, mais non constant, d'une atteinte hépatobiliaire.

09 · Asymptomatique : Qui ne s'accompagne pas de symptôme perceptible ; ce terme n'exclut ni infection, ni contagiosité, ni évolution.

10 · Chronicité : Persistance dans le temps ; le cours situe l'hépatite chronique au-delà de six mois.

11 · Insuffisance hépatique : Défaillance des fonctions du foie, notamment de sa capacité de synthèse, avec des conséquences potentiellement graves.

12 · Hépatite fulminante : Forme aiguë grave associant insuffisance hépatique et encéphalopathie, pouvant s'accompagner de défaillances d'autres organes.

13 · Encéphalopathie hépatique : Trouble neurologique lié à la défaillance hépatique, se manifestant notamment par une altération de la conscience.

14 · Fibrose : Constitution de tissu cicatriciel dans le foie au cours d'une atteinte persistante.

15 · Cirrhose : Remaniement chronique de l'architecture hépatique avec fibrose, exposant à des complications fonctionnelles et à un cancer du foie.

Définitions et mots-clés — Transmission et diagnostic

16 · Hypertension portale : Augmentation de pression dans le système porte, liée dans le cours à la résistance au passage du sang dans un foie cirrhotique.

17 · Ascite : Accumulation de liquide dans la cavité abdominale, décrite parmi les complications de la cirrhose.

18 · Circulation collatérale : Développement de voies veineuses de dérivation lorsque la circulation habituelle rencontre un obstacle.

19 · MASH : Stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, citée parmi les causes non virales d'hépatite chronique.

20 · Incubation : Intervalle entre la contamination et l'apparition éventuelle des symptômes.

21 · Capside : Structure protéique entourant le génome viral.

22 · Virus nu / enveloppé : Un virus nu possède une capside sans enveloppe lipidique ; un virus enveloppé possède en plus cette enveloppe. Le cours relie cette différence aux conditions de transmission.

23 · Réservoir : Hôte ou milieu dans lequel un agent infectieux se maintient et à partir duquel une contamination peut survenir.

24 · Zoonotique : Qui concerne une infection dont le réservoir ou la transmission implique des animaux ; le porc et le sanglier sont cités pour E.

25 · Transmission féco-orale : Transmission dans laquelle un agent issu des selles atteint la bouche, directement ou par l'eau, les mains, les objets ou les aliments.

26 · Transmission parentérale : Transmission hors du tube digestif dans la comparaison du cours ; la voie exacte, notamment sanguine, doit être précisée.

27 · Dépistage : Recherche d'une infection ou d'un statut chez une personne, notamment avant les symptômes ou les complications.

28 · Sérologie : Recherche de marqueurs immunologiques dans le sang, par exemple des anticorps ou un antigène viral.

29 · Antigène : Élément reconnu par le système immunitaire ; HBs est l'antigène de surface utilisé dans le bilan et le vaccin B.

30 · Anticorps : Protéine de la réponse immunitaire dirigée contre un antigène ; sa présence ne signifie pas toujours infection active.

Définitions et mots-clés — Marqueurs et prévention

31 · IgM : Classe d'immunoglobulines utilisée dans les recherches d'infection aiguë décrites ; l'interprétation dépend du marqueur recherché et du contexte.

32 · AgHBs : Antigène de surface du virus B ; sa détection fait rechercher une infection en cours.

33 · Anti-HBs : Anticorps dirigés contre HBs, produits notamment après vaccination B.

34 · Anti-HBc : Anticorps dirigés contre la capside du virus B, témoignant d'un contact avec ce virus dans le bilan enseigné.

35 · Anti-VHC : Anticorps dirigés contre le virus C ; ils peuvent persister après la guérison et ne suffisent pas à prouver une infection active.

36 · ARN viral / charge virale : Matériel génétique recherché pour le VHC ; sa détection et sa quantification renseignent sur le virus circulant.

37 · PCR : Technique de détection du matériel génétique, citée dans le dépistage du génome viral.

38 · DGV : Dépistage du génome viral dans un don de sang, complémentaire des contrôles du donneur présentés à l'oral.

39 · AES : Accident d'exposition au sang, nécessitant le recours au circuit de prise en charge et l'évaluation des expositions.

40 · Vaccin sous-unitaire : Vaccin contenant un constituant ciblé de l'agent infectieux ; pour B, l'antigène HBs.

41 · Immunisation : État de protection immunitaire à établir dans le cadre approprié ; avoir reçu des injections ne suffit pas à présumer une réponse chez tous.

42 · Non-répondeur vaccinal : Personne ne développant pas la réponse anti-HBs attendue après les schémas complets décrits ; statut établi médicalement.

43 · Immunoglobulines spécifiques : Anticorps administrés pour apporter une protection passive immédiate dans les situations indiquées.

44 · Sérovaccination : Association d'un vaccin et d'immunoglobulines spécifiques ; le cours la décrit chez le nouveau-né de mère AgHBs positive.

45 · Adhésion au traitement : Participation durable de la personne à la prise du traitement et au suivi convenus, soutenue notamment par l'information et l'accompagnement infirmier.